Крауроз: есть решение

Крауроз вульвы – название несколько загадочное, немного иностранное. В реальности за ним скрываются хронические дистрофические, атрофические изменения наружного анатомического отдела женских половых органов. При этом патология считается еще не достаточно изученной, что затрудняет выбор схемы лечения. Однако, современная медицина, пожалуй, способна предложить инновационный метод коррекции негативных изменений.

Что к чему?

Хронические дистрофические, атрофические заболевания вульвы (больших и малых половых губ, лобка, клитора, преддверия влагалища) даже в XXI веке относятся к наименее изученным заболеваниям. Этот факт определяет наличие множества названий, используемых для определения изменений тканей: «крауроз вульвы», «склеротический лишай», «склеротический дерматит», «склерозирующий лихен», «атрофический вульвит», «гиперпластический вульвит», «простой хронический лишай», «синильная атрофия». Обобщающий термин, который часто применяют специалисты, звучит, как неопухолевые заболевания вульвы. Терапией нарушений занимаются дерматологи, гинекологи, эндокринологи, онкологи. Однако, согласитесь, обратится к специалисту по кожным болезням или раковым опухолям, в том случае, если возникает дискомфорт, в зоне промежности, куда сложнее, чем к лечащему гинекологу.

Что за понятия?

- Дистрофия - процесс, ведущий к изменению нормальной функции органа, связанный с нарушением обменных процессов.
- Атрофия - истощение ткани, вызванное снижением жизнедеятельности клеток организма, провоцирующее ишемию (нарушение кровоснабжения), приводящее к уменьшению ткани или органа, патологическому изменению функции.

При заболеваниях, и, в частности, при краурозе вульвы, обе негативные тенденции могут сочетаться, провоцируя атрофию больших и малых половых губ, воспалительные изменения вульвы, трещины вульвы. Что может сопровождаться урологическими нарушениями, опущением и выпадением матки, снижением качества сексуальной жизни, которое обусловлено сужением влагалища, атрофией клитора. Согласно медицинским источникам, патология достаточно часто рассматривается, как предраковое заболевание. Поэтому, эффективная

терапия дистрофических, атрофических процессов может выступать профилактической мерой возникновения рака вульвы.

Что провоцирует?

Факторами, предрасполагающими к развитию патологических процессов, могут стать:

- наступление пери- и постменопаузы, и сопутствующая гормональная перестройка, происходящая в организме женщины; при этом остается открытым вопрос, почему на фоне возрастных изменений у некоторых женщин изменения состояния половых тканей компенсируются, а у других приводят к развитию крауроза;
- нарушения в функционировании нервной системы, стрессы;
- иммунные заболевания;
- инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ);
- укороченный репродуктивный период (позднее половое созревание, ранний климакс);
- гормональные сбои, эндокринные нарушения (гипоэстрогения, сахарный диабет, ожирение);
- несоблюдение личной гиены (среди провокаторов, врачи называют и ношение синтетического нижнего белья);
- механическое раздражение;
- инфекционный фактор (кандидоз).

Число случаев заболевания, по данным различных источников различается и составляет от 1 на 300 до 1 на 1000 женщин.

Что заставит пойти к врачу?

Основной симптом крауроза вульвы – сильный хронический зуд, который сложно купировать медикаментами. Кроме того, отмечается появление белых пятен в месте поражения тканей. При подобном дискомфорте важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Течение дистрофических процессов может быть своевременно остановлено.

Что может помочь?

Основными методами терапии неопухолевых заболеваний вульвы до недавнего времени считались:

- Диетотерапия – ограничение потребления острой, соленой, сладкой пищи, исключение алкоголя и кофе. Иными словами, продуктов способных усилить или спровоцировать зуд.
- Назначение кортикостероидных мазей, обладающих противовоспалительным, антигиперпластическим, противоаллергическим эффектом. Однако, минус их назначения – невозможность длительного применения из-за риска рубцовых изменений.
- Местные гормональные средства (эстрогенные препараты), оказывают противовоспалительное и противозудное действие.

- Аппликации озонированного оливкового масла, которое оказывает бактерицидный эффект и усиливает питание тканей.

Все перечисленные терапевтические меры направлены на улучшение состояния наружных половых органов, устранение местного воспаления и устранение активных жалоб пациента, но не могут излечить заболевание полностью. В некоторых случаях показано и хирургическое лечение, пластическая операция по восстановлению вульвы.

Что такое инновационные технологии?

И технологии в гинекологии не стоят на месте. Один из современных методов лечения крауроза вульвы - лазерная терапия с применением фракционного CO2 лазера на аппарате Eraser-C-RF.

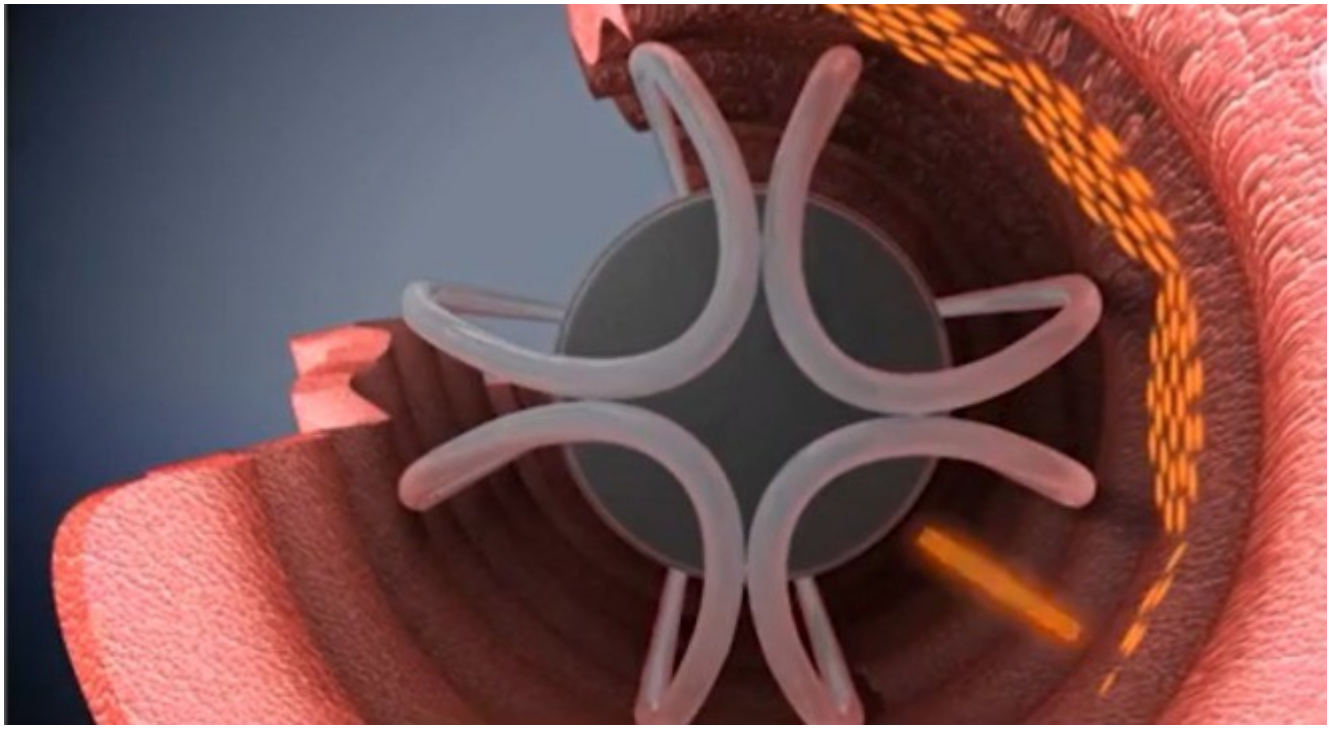


CO2 лазерные системы позволяют пациенткам пройти сеансы, стимулирующие улучшение питания тканей половых органов, их обновление, что может помочь в лечении дегенеративных изменений крауароза вульвы, а это в свою, очередь предпосылка для улучшения физического состояния, нормализации сексуальной жизни, восстановления психологического комфорта. Иначе, возможность жизнь полноценной жизнью долгие годы.

Процесс воздействия лазера на гениталии можно сравнить с нанесением на ткань микроскопического узора – сетки, где чередуются обработанные и необработанные участки. Контролируемое повреждение запускает механизмы естественной регенерации тканей. Затронутые лазером зоны активно синтезируют соединительнотканные волокна, позволяя обеспечить своеобразный лечебный и омолаживающий эффект.

Специалист Клиники Современных Технологий (КСТ), врач акушер-гинеколог, специалист по комплексному вульво-генитальному лазерному ремоделированию,

Наталья Николаевна Валентинова, имея обширную практику ведения пациенток с крауарозом вульвы, говорит о том, что всего после двух-трех процедур микроимпульсного воздействия CO2 лазером на ткани половых органов женщины начинаются процессы, приводящие к обновлению клеток коллагена (неоколлагенезу) и торможению негативных процессов.



Что очень важно, лазерные процедуры выполняются в амбулаторных условиях, не требуют длительной и изматывающей подготовки и восстановления. Лазер сразу же прижигает поврежденные сосуды, уменьшая риск кровотечений, и снижая болезненность в период реабилитации. Все параметры воздействия лазера специалисты подбирают строго индивидуально, что может позволить свести риски от вмешательства почти к нулю. Проходя лечения можно вести привычный образ жизни. Возврат к половой жизни возможен уже через 72 часа после проведения процедуры.

Главное помнить, что из любой ситуации, даже на первый взгляд загадочной и не до конца изученной, можно найти выход, главное иметь знания о возможностях современной медицины.